LÝ THUYẾT · MẮT

BÀI 4 Đục thủy tinh thể

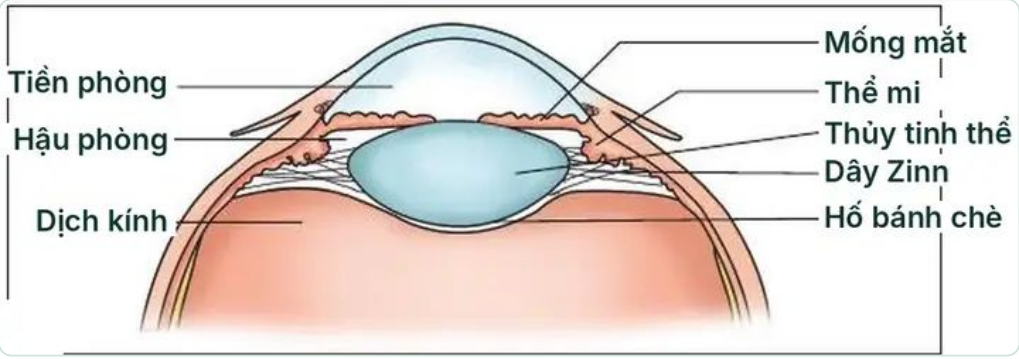
Biên soạn lại từ bài giảng 4. Cataract - Diagnosis & Treatment.pdf (23 trang) · Giải thích dễ hiểu, kèm 9 hình minh hoạ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIẢI PHẪU THỦY TINH THỂ
2. TỔNG QUAN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ
3. TRIỆU CHỨNG
4. CÁC HÌNH THÁI ĐỤC THỦY TINH THỂ
5. BIẾN CHỨNG
6. ĐIỀU TRỊ

Học xong bài này, bạn cần: trình bày được giải phẫu thủy tinh thể; nêu dịch tễ và yếu tố nguy cơ của đục thủy tinh thể; chẩn đoán được đục thủy tinh thể; nêu được các phương pháp điều trị.

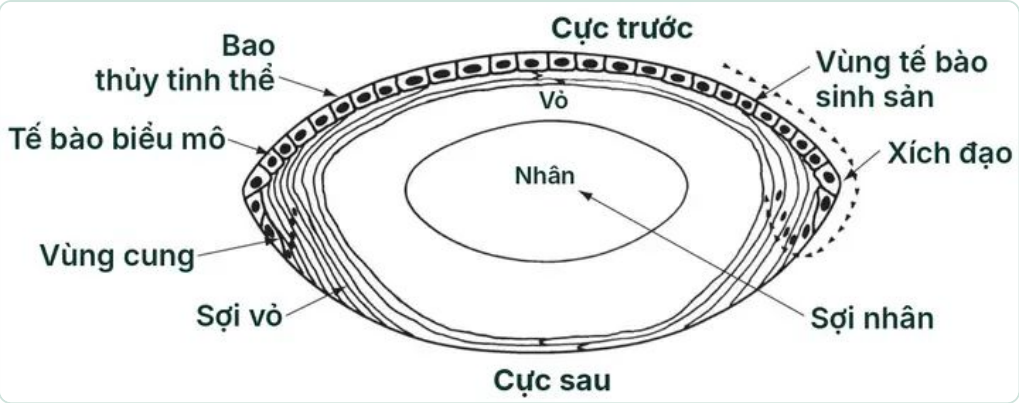
1. GIẢI PHẪU THỦY TINH THỂ

- Thủy tinh thể (TTT) nằm **ngay sau mống mắt**, trước dịch kính, được treo vào **thể mi** nhờ các **dây Zinn**.



Hình 1. Vị trí thủy tinh thể ở phần trước nhãn cầu.

- Đặc điểm:
  - Là một **thấu kính hội tụ, trong suốt**.
  - **Không có mạch máu, không có thần kinh**.
  - Công suất khúc xạ **khoảng +20D**.
- **3 phần chính: bao TTT**, **vỏ TTT**, **nhân TTT**.
  - **Bao TTT:** màng **bán thấm** với nước và chất điện giải.
  - **Biểu mô TTT** (nằm dưới bao trước): chuyển hóa và phân bào, **biệt hóa thành sợi TTT**.
  - **Vỏ và nhân TTT:** tạo thành từ các sợi TTT. **Sợi cũ bị nén dần vào trong** tạo thành nhân.



Hình 2. Cấu trúc thủy tinh thể: biểu mô ở vùng xích đạo sinh ra sợi mới; sợi cũ bị đẩy dần vào trung tâm thành nhân.

- **Vai trò:** duy trì **độ trong suốt**; **khúc xạ ánh sáng**; thực hiện **chức năng điều tiết** (thay đổi độ phồng để nhìn rõ ở gần).

> **Hiểu nhanh:** TTT giống như **củ hành**: lớp sợi mới liên tục được đắp thêm ở ngoài, lớp cũ bị ép vào giữa. Vì vậy tuổi càng cao, **nhân càng to, càng cứng và kém trong** – đó là lý do đục TTT gắn liền với tuổi già. "Đục thủy tinh thể" chính là khi thấu kính này **mất độ trong suốt**.

2. TỔNG QUAN VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ

- Là **nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực** trên thế giới cũng như tại Việt Nam.
- Xuất hiện ở **mọi lứa tuổi**, đặc biệt **trên 50 tuổi**.
- **Nữ giới chiếm 2/3.**
- **Yếu tố nguy cơ:**
  - **Tuổi.**
  - **Sử dụng steroid kéo dài.**
  - **Hút thuốc lá.**
  - **Tiếp xúc tia UV.**
  - **Uống nhiều rượu bia.**
  - **Phẫu thuật nội nhãn.**
  - **Bệnh lý toàn thân** (đái tháo đường...).

3. TRIỆU CHỨNG

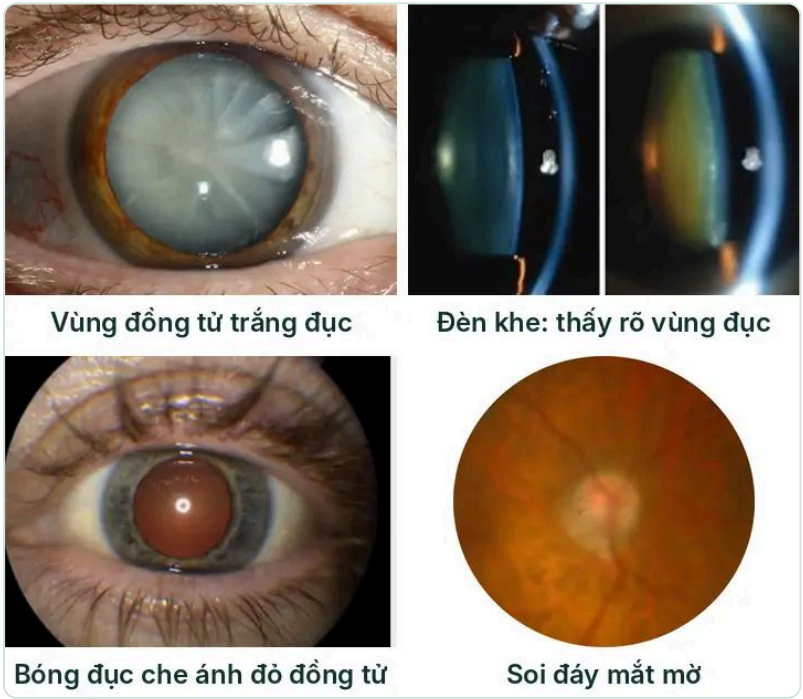
- **Nhìn mờ** tăng dần; mắt **không đỏ, không đau, không cộm xốn**.
- **Lóa mắt:** ánh sáng bị **tán xạ** khi đi qua vùng đục, nhất là khi nhìn đèn xe ban đêm.
- **Song thị một mắt:** vùng đục làm ánh sáng bị khúc xạ không đều, tạo hai ảnh; **che mắt kia vẫn thấy đôi**.
- **Cận thị giả:** nhân đục, cứng làm TTT **hội tụ mạnh hơn** → mắt trở nên "cận".



Hình 3. Đục thủy tinh thể làm cảnh vật mờ đi như nhìn qua màn sương.

Vì sao có người già bỗng đọc sách không cần kính lão? Đó là **cận thị giả** do đục nhân: TTT hội tụ mạnh hơn nên nhìn gần lại rõ, nhưng **nhìn xa thì mờ**. Đây không phải mắt "khỏe lại" mà là dấu hiệu đục TTT đang tiến triển.

Mẹo phân biệt: đỏ mắt + đau → nghĩ bệnh cấp (Bài 1). **Mờ từ từ, mắt trắng, không đau** ở người lớn tuổi → nghĩ **đục TTT** (hoặc glôcôm góc mở – Bài 5).



Hình 4. Khi khám: vùng đồng tử trắng đục, đèn khe thấy rõ vị trí đục, bóng đục che ánh đỏ đồng tử và đáy mắt nhìn mờ.

4. CÁC HÌNH THÁI ĐỤC THỦY TINH THỂ

Đục TTT do tuổi



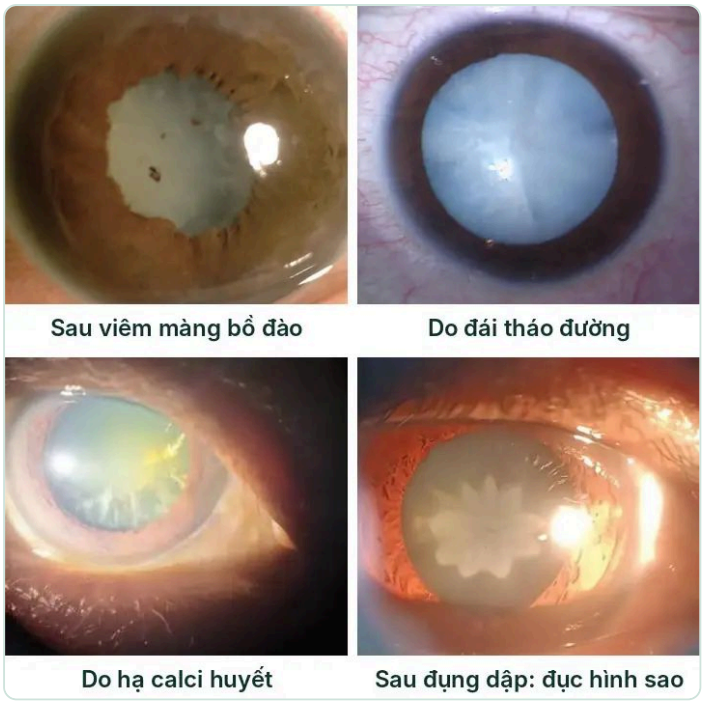
Hình 5. Ba hình thái đục do tuổi: đục nhân, đục vỏ và đục dưới bao sau.

Hình thái	Đặc điểm
Đục nhân	Tiến triển **chậm, 2 mắt**, có thể không cân đối; ảnh hưởng **thị lực nhìn xa**; **cận thị giả**
Đục vỏ	**Luôn luôn ở 2 mắt**, thường không cân xứng; **lóa mắt**; **dễ gây tăng nhãn áp thứ phát**
Đục dưới bao sau	Gặp ở **người trẻ tuổi**; **ra sáng nhìn mờ hơn trong tối**; phải khám dưới **đèn khe và đồng tử giãn**

> **Vì sao đục dưới bao sau lại "ra sáng mờ hơn"?** Vùng đục nằm ngay **trung tâm, phía sau**. Ra nắng, đồng tử co nhỏ lại, ánh sáng chỉ đi qua đúng vùng đục → mờ hẳn. Vào chỗ tối, đồng tử giãn, ánh sáng đi được qua phần ngoại vi còn trong → nhìn đỡ hơn.

Đục TTT do bệnh lý

- **Thứ phát sau viêm màng bồ đào (VMBĐ):**
  - Do **viêm kéo dài không kiểm soát**.
  - **Dính mống mắt vào mặt trước TTT** do sắc tố, xuất tiết.
  - **Phẫu thuật phức tạp, kết quả không cao.**
- **Do đái tháo đường:**
  - Người trẻ: **xuất hiện đột ngột, tiến triển nhanh**.
  - Người già: xuất hiện **sớm hơn** người không đái tháo đường, hình thái **giống đục TTT người già**.
- **Do hạ calci huyết:**
  - **Thường 2 mắt.**
  - **Chấm đục óng ánh** ở mặt trước và mặt sau TTT.
  - Có thể **ổn định** hoặc tiến triển thành **đục vỏ hoàn toàn**.



Hình 6. Đục thủy tinh thể do bệnh lý và do chấn thương.

Đục TTT do thuốc

- **Corticosteroid.**
- **Thuốc hướng tâm thần** (Phenothiazine).
- **Thuốc tim mạch** (Nifedipine, Methyldopa).

Đục TTT do chấn thương

- **Đụng dập nhãn cầu:**
  - Đục **nhanh hoặc âm ỉ**, **một phần hoặc toàn bộ**.
  - Dấu hiệu: **vòng Vossius** (vòng sắc tố mống mắt in lên mặt trước TTT), **đục hình sao**, **bán lệch TTT**.
- **Chấn thương xuyên:**
  - **Đục vỏ tại vị trí rách** bao, sau đó **diễn tiến đến đục toàn bộ**.
  - Đi kèm tổn thương khác: **đứt chân mống, dị vật nội nhãn**...
- **Chấn thương khác:** do **bức xạ**, **tia hồng ngoại**, **tia tử ngoại**, **hóa chất**, **điện**.

Đục TTT bẩm sinh

- **1 mắt hoặc cả 2 mắt.**
- **Yếu tố nguy cơ:** cha mẹ mắc **giang mai**, **đồng huyết thống**, **mẹ nhiễm Rubella trong 3 tháng đầu thai kỳ**.
- **Phẫu thuật càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trước 3 tháng tuổi.**

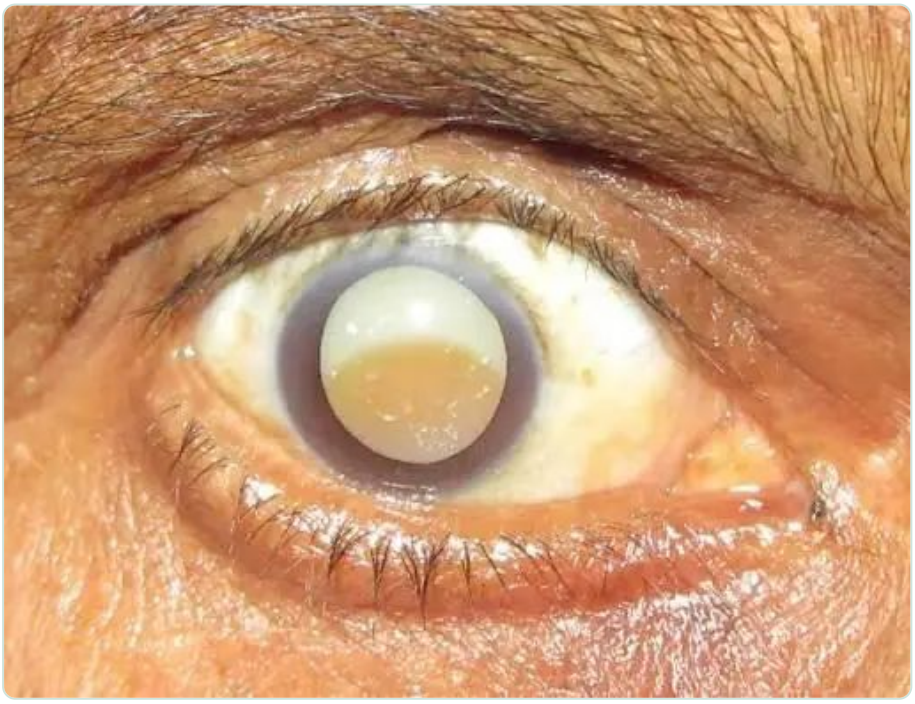


Hình 7. Đục thủy tinh thể bẩm sinh: đồng tử trắng; soi ánh đồng tử giúp phát hiện sớm.

> **Vì sao phải mổ sớm như vậy?** Những tháng đầu đời là giai đoạn não **học cách nhìn**. Nếu TTT đục che hình ảnh trong giai đoạn này, não không phát triển được chức năng thị giác cho mắt đó (**nhược thị**), mổ muộn thì dù TTT đã trong, mắt vẫn nhìn kém suốt đời.

5. BIẾN CHỨNG

- **Tăng nhãn áp thứ phát.**
- **Bao TTT vỡ** → nhân rơi vào **dịch kính** hoặc ra **tiền phòng** → **viêm màng bồ đào kèm tăng nhãn áp**.
- **Giảm thị lực nghiêm trọng.**



Hình 8. Đục thủy tinh thể để quá lâu: vỏ hóa lỏng, nhân chìm xuống dưới. Đây là giai đoạn dễ gây biến chứng.

Thông điệp cho bệnh nhân: đục TTT **không phải đợi "chín" mới mổ**. Để quá lâu, TTT căng phồng hoặc vỡ bao có thể gây **tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào**, và cuộc mổ cũng khó hơn.

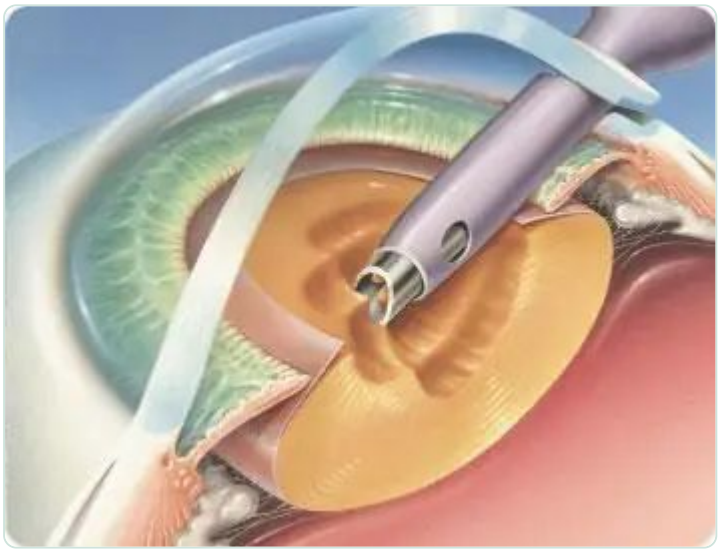
6. ĐIỀU TRỊ

Nội khoa

- Chỉ dùng ở **giai đoạn chưa có chỉ định phẫu thuật**: các thuốc nhỏ như **C. Kary Uni, C. Quinax, C. Catacol**...
- **"Giả cận thị"** → **đeo kính tạm thời**.
- Thuốc **không làm TTT đã đục trong trở lại**; điều trị triệt để là **phẫu thuật**.

Ngoại khoa

- **Phẫu thuật lấy TTT trong bao:** lấy toàn bộ TTT cùng với bao.
- **Phẫu thuật lấy TTT ngoài bao:** lấy nhân và vỏ, **giữ lại bao sau**.
- **Phẫu thuật tán nhuyễn TTT bằng siêu âm (Phaco):** qua **vết mổ nhỏ**, đầu siêu âm tán nhuyễn nhân rồi hút ra.
- Sau khi lấy TTT, thường **đặt thủy tinh thể nhân tạo** để thay cho công suất khoảng +20D đã mất.



Hình 9. Phaco: đầu siêu âm đưa qua vết mổ nhỏ để tán nhuyễn và hút thủy tinh thể đục.

Ghi nhớ cả bài: TTT là thấu kính **trong suốt, không mạch máu**, +20D. Đục TTT gây **mờ từ từ, không đỏ, không đau**, kèm lóa, song thị một mắt, cận thị giả. Ba hình thái do tuổi: **nhân – vỏ – dưới bao sau**. Điều trị triệt để là **phẫu thuật**, với trẻ bẩm sinh thì **mổ trước 3 tháng tuổi**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ bài giảng 4. Cataract - Diagnosis & Treatment.pdf. Hình minh hoạ lấy từ bài giảng, nhãn đã dịch sang tiếng Việt. Đối chiếu bài giảng gốc khi cần chi tiết.